

Behandlung und Ambivalenz

Wenn Ablehnung
mit Gefahr
zusammenfällt

Wenn fehlende Einsicht oder Behandlungsabbruch mit akuter Gefährdung
zusammenkommen, endet der Gesprächsrahmen: Notfallseite nutzen und
sofort 144 oder 0800 33 66 55 anrufen.

- | | |
|---|---|
| 1 | Nicht im Streit über Behandlung diskutieren |
| 2 | Beobachtungen dokumentieren und Behandlungsteam informieren |
| 3 | In stabileren Phasen Gründe, Grenzen und Plan B klären |

Warum Behandlung oft ambivalent bleibt

Viele Angehörige erleben dieselbe Frage immer wieder: Warum wird Hilfe abgelehnt, obwohl sie sichtbar nötig wäre? Die Antwort ist selten schlicht. Nebenwirkungen, Scham, Müdigkeit, Autonomiebedürfnis oder die Erfahrung, dass sich Hypomanie subjektiv eher nach Kraft als nach Krankheit anfühlt, machen Behandlung innerlich widersprüchlich.

Ambivalenz ist nicht automatisch fehlende Einsicht

Es macht einen Unterschied, ob jemand in einer akuten manischen Phase die eigene Lage neurobiologisch nicht realistisch erkennen kann oder ob Behandlung in stabileren Phasen ambivalent erlebt wird. Im zweiten Fall gibt es oft noch Gesprächsspielraum. Im ersten Fall helfen Debatten meist kaum.

Was in ambivalenten Phasen eher hilft

- in ruhigerem Moment sprechen, nicht mitten im Streit
- Sorgen als Ich-Botschaft formulieren
- konkrete Beobachtungen benennen statt Diagnosen verteilen
- nach Gründen fragen, bevor Lösungen vorgeschlagen werden
- das Behandlungsteam informieren, auch wenn Sie keine Rückmeldung bekommen dürfen
- Beobachtungen weitergeben: Sie dürfen Informationen geben, auch ohne Einwilligung

Ein hilfreicher Einstieg kann sein:

„Ich mache mir Sorgen, weil ich seit dem Absetzen Veränderungen sehe. Können wir darüber in Ruhe sprechen?“

Was eher nicht hilft

- im Konflikt über Medikamente diskutieren
- Heimlichkeit oder Kontrolle statt Absprache
- Entscheidungen unter Druck erzwingen
- so tun, als wäre nichts passiert
- alles allein tragen, bis die Lage eskaliert

Wenn Medikamente abgesetzt wurden

Das Absetzen von Medikamenten ist kein exotischer Sonderfall, sondern ein vorhersehbares Risiko. Reagieren Sie nicht nur aus Panik. Sinnvoller ist: beobachten, dokumentieren, das Behandlungsteam informieren, in ruhigem Moment nach Gründen fragen und einen Plan B benennen, falls die Lage kippt. Sie brechen keine Schweigepflicht, wenn Sie Ihre Beobachtungen mitteilen.

Ihre Grenze darf sichtbar werden

Eine klare Grenze ist kein Verrat. Sie dürfen sagen:

„Wenn ohne Behandlung eine Episode kommt, kann ich die Verantwortung nicht allein tragen. Dann brauchen wir Hilfe von aussen.“

Solche Sätze drohen nicht. Sie machen Realität besprechbar.

Nächster sinnvoller Schritt

Klären Sie in einer stabileren Phase drei Punkte: Welche Nebenwirkungen oder Ängste belasten besonders? Wer wird informiert, wenn Medikamente abgesetzt werden? Ab welchem Punkt greift der Krisenplan oder der Notfallpfad?

Weiterführend:

- Modul 6: Wenn Krankheitseinsicht fehlt oder Behandlung scheitert
 - Modul 6: Medikamente absetzen
 - Krisenplan-Werkzeug
 - Notfallseite
-

Quellen (Auswahl)

1. NICE (CG185): Bipolar disorder: assessment and management. Last updated 2025-09-02. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg185>
2. DGBS, DGPPN und AWMF (2019/2020): S3-Leitlinie Diagnostik und Therapie Bipolarer Störungen. <https://dgb.de/verein/s3-leitlinie/>
3. Yatham et al. (2018): CANMAT/ISBD guidelines for bipolar disorder. Bipolar Disorders. <https://doi.org/10.1111/bdi.12609>